



PROTOCOLO DE PROFILAXIS “TARTRECTOMÍA”

Clínica Universitaria de Odontología

Se realizará exclusivamente en aquellos casos en que haya presencia de sarro y que la placa bacteriana se eliminará con cepillado.

En los niños puede ser suficiente aplicar los ultrasonidos (U.S) en aquellos dientes en los que haya depósitos de sarro, en el resto de los dientes, se puede utilizar el cepillo de profilaxis.

NORMAS GENERALES DE APLICACIÓN DE LOS U.S:

1. Las puntas del U.S. no deben utilizarse **nunca perpendicularmente al diente**.
2. Debe trabajarse con **ángulos de 15-30°** respecto a la superficie del diente o, incluso, paralelos, dependiendo del tipo de punta aplicada.
3. Se aplicará la punta sobre el diente con **ligera presión**, desplazándola con **movimientos de ida y vuelta** en uno y otro sentido.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN:

En el caso de que esté indicada la tartrectomía en todos los dientes es muy importante establecer una **sistemática en la ejecución** del trabajo:

1. Se comenzará en el extremo de una arcada, por ejemplo, en distal del primer cuadrante por la cara vestibular
2. A continuación, se continuará por esa cara hasta alcanzar la porción distal del 2º cuadrante.
3. Seguidamente haríamos lo mismo por la cara palatina hasta completarla. Posteriormente, seguiríamos en un orden similar en la arcada inferior.

4. Una vez que se haya terminado de pasar el aparato de U.S, examinaremos todas las superficies para asegurarnos de que no queda **ningún depósito de sarro** sobre ellas, para lo que nos serviremos de una sonda periodontal.
5. Tras lo cual, procederemos a la **eliminación de tinciones y manchas** mediante la utilización de **pasta abrasiva**. Esta se aplicará mediante un cepillo o copa que se inserta en el contraángulo de profilaxis: se coge una pequeña cantidad de pasta con el cepillo de profilaxis y se aplica a la cara vestibular de últimos molares de primer cuadrante y se extiende por los dientes adyacentes; se pone en marcha el contraángulo y se procede a la limpieza de las superficies (sin agua); se continúa con este procedimiento siguiendo el orden establecido por toda la arcada y por la antagonista. Al terminar se puede pasar el contraángulo con agua o, lo que es mejor, se le manda al paciente que se enjuague.
6. Se realizará una nueva revisión en busca de posibles manchas que puedan haber quedado, para eliminarlas en un nuevo intento.
7. A continuación, se hace una aplicación de gel de flúor. Para ello, se echa este gel en unas cubetas especiales para tal fin. Debemos de tomar una serie de **precauciones** para minimizar los posibles riesgos derivados de una ingestión masiva de gel:
 - No debe llenarse más del 40% de la cubeta, es decir, unos 2 ml de gel.
 - El paciente permanecerá sentado, con la cabeza inclinada hacia delante.
 - Se utilizará la aspiración entre las dos cubetas durante todo el proceso.
 - Se instruirá al paciente para que escupa el exceso de flúor.
 - Las cubetas se mantendrán en la boca 1 minuto como mínimo, aunque debemos intentar mantenerlas hasta 4 minutos.
 - Recomendaremos al paciente que se abstenga de ingerir líquidos o alimentos durante los siguientes 30 minutos y que evite los lácteos hasta el día siguiente.
8. Para terminar, **instruiremos** al paciente sobre **la técnica de cepillado**, valiéndonos para ello de un Tipodonto.

Debemos extremar las precauciones en:

1. Obturaciones:
 - de resina→ posibles fracturas
 - de amalgama→ lesiones marginales
2. Aparatología de ortodoncia fija
3. Caries
4. Dientes afectados por hipomineralización incisivo-molar
5. En lesiones tipo “manchas blancas”, hipoplasias de esmalte, etc.